

③

免疫チェックポイント阻害薬

irAEの考え方とCTCAE Gradeに応じた対応

1 主な薬剤と標的分子

抗PD-1抗体

ニボルマブ、ペムブロリズマブ — T細胞上のPD-1を阻害し免疫抑制を解除

抗PD-L1抗体

アテゾリズマブ、デュルバルマブ — がん細胞側のPD-L1を阻害

抗CTLA-4抗体

イピリムマブ — T細胞活性化に対する抑制シグナルを阻害

2 免疫関連有害事象(irAE)の代表例



皮膚:皮疹・痒感(頻度が高いirAE)



消化器:大腸炎・下痢(Grade3以上で入院・ステロイド治療を要すること)



内分泌:甲状腺機能異常、下垂体炎、1型糖尿病



心筋炎:頻度は低いが劇症化しやすく致死率が高い

3 irAE管理の基本

- ☐ Grade2以上のirAEでは、休薬とステロイド治療の開始が基本方針となる
- ☐ Grade3～4では高用量ステロイド・免疫抑制薬(インフリキシマブ等)の追加を検討する
- ☐ irAEは投与終了後も遅れて出現しうるため、治療終了後も症状に注意する
- ☐ 心筋炎は倦怠感・動悸など非特異的症候で発症することがあり、疑ったら緊急対応が必要

irAEは「いつ」「どの臓器に」起こるか予測が難しい。だからこそ、あらゆる新規症状を『まずirAEを疑う』姿勢が重要になる。